AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

ASOFAMECh PERFIL V3



TOMO 19 · OB · ATLAS

ATLAS DE IMÁGENES EUNACOM ·

OBSTETRICIA

Lo que tienes que ver en cada foto, y qué hacer después

42 IMÁGENES COMENTADAS CON MARCADORES	**16** TEMAS, EN EL ORDEN DEL TOMO	**2** PARES «PARECIDAS PERO DISTINTAS»

Módulo 3 · Materno - Infantil · complemento visual del Tomo 19

Índice por tema

Cómo usarlo. Mira primero la foto y busca tú los hallazgos; después compara con los marcadores numerados y con «Qué tienes que ver». Cierra con la conducta y la pregunta real del pie. Al final, pruébate sin respuestas en la Autoevaluación.

Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento. «Tomo p.» = página del Tomo 19 donde se trata esa imagen o su tema.

Parecidas pero distintas 25

Índice por tipo de imagen 27

Soluciones de la autoevaluación 29

Signos con nombre propio 26

Autoevaluación 28

01 Control Prenatal & Evaluación Fetal

19.2 Ecografía Obstétrica

01 Longitud céfalo-nalgas 4

02 Translucencia nucal normal 4

03 Translucencia nucal aumentada 5

19.3 Evaluación del Bienestar Fetal

04 Registro cardiotocográfico reactivo 5

05 Registro basal no estresante 6

19.4 Restricción del Crecimiento Fetal (RCF)

06 Doppler de arteria umbilical normal 6

07 Arteria cerebral media vasodilatada 7

08 Flujo diastólico ausente 7

09 Doppler umbilical alterado 8

10 Ductus venoso con onda a reversa 8

11 Doppler de arteria cerebral media 9

02 Patologías Médicas del Embarazo

19.7 Diabetes Gestacional y Pregestacional

12 Macrosomía: grasa subcutánea aumentada 9

19.21 Cardiopatía, Embarazo Múltiple e Hiperemesis Gravídica

13 Corionicidad y amnionicidad 10

14 Signo lambda: bicorial 10

15 Monocorial: membrana fina 11

16 Transfusión feto-fetal 11

03 Metrorragias de la Primera y Segunda Mitad del Embarazo

19.10 Aborto Espontáneo, Formas Clínicas, Aborto Séptico y Ley IVE 21.030

17 Gestación interrumpida 12

18 Restos ovulares con Doppler 12

19 Embrión y restos expulsados 13

19.11 Embarazo Ectópico

20 Líquido libre en el Douglas 13

21 Embarazo ectópico ampular 14

22 Útero vacío y β-hCG 14

19.12 Enfermedad Trofoblástica Gestacional

23 Mola completa: tormenta de nieve 15

24 Mola: vesículas sin embrión 15

19.13 Metrorragias de la Segunda Mitad del Embarazo

25 Placenta previa en la ecografía transvaginal 16

26 Placenta previa vs DPPNI 16

27 Tipos de placenta previa 17

28 Vasa previa 17

04 Parto Prematuro, Mecanismo del Parto, Puerperio & Urgencias Obstétricas

19.14 Rotura Prematura de Membranas (RPM), Latencia, Profilaxis Antibiótica y Corioamnionitis

29 Test de helecho 18

19.15 Síndrome de Parto Prematuro

30 Cervicometría 18

19.16 Trabajo de Parto Normal, Mecanismos del Parto en Cefálica, Score de Bishop y Manejo Activo del Alumbramiento

31 Partograma 19

32 Variedades de posición 19

19.17 Distocias del Trabajo de Parto, Distocia de Hombros y Monitorización Intraparto (CTG FIGO)

33 Signo de la tortuga 20

34 McRoberts y presión suprapúbica 20

35 Desaceleraciones precoces 21

Índice por tema · continuación

19.18 Hemorragia Postparto Inmediata (HPI), Código Rojo, Regla de las 4T y Algoritmo Terapéutico Escalonado

36 Balón de Bakri 21
37 Balón de Bakri y sutura de B-Lynch 22
38 Inversión uterina 22

19.19 Infecciones Puerperales

39 Absceso mamario 23
40 Mastitis abscedada: clínica y ecografía 23

19.20 Aloinmunización Rh e Incompatibilidad de Grupo Materno-Fetal

41 Doppler de ACM en aloinmunización 24
42 Hidrops fetal 24

01 TEMA 19.2 · ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA

ECOGRAFÍA

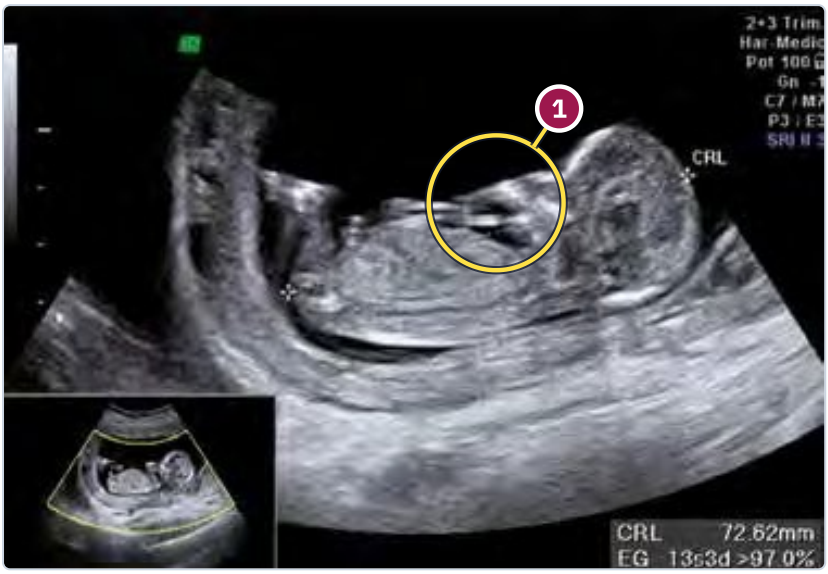


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 117

QUÉ TIENES QUE VER

1 LCN

DIAGNÓSTICO

Longitud céfalo-nalgas

Medición del embrión en el primer trimestre.

CONDUCTA INICIAL

La ecografía precoz fecha mejor el embarazo.

3.01.3.003	Determinación de edad gestacional	examen/procedimiento
3.01.4.003	Ecotomografía obstétrica normal	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Biometría tardía: error mayor.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2018 · P90 «Una paciente con antecedente de reglas irregulares, que ocurren cada 45 a 60 días, se realiza un test de embarazo, que resulta positivo. Tiene…» → **Medición ecográfic…**

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL
p. 9
Tema 19.2

Clase 19.2 en video

02 TEMA 19.2 · ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA

ECOGRAFÍA



Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 117

QUÉ TIENES QUE VER

1 Translucencia nucal

DIAGNÓSTICO

Translucencia nucal normal

Espacio nucal menor de 3 mm.

CONDUCTA INICIAL

Ecografía 11–14 semanas.

3.01.4.003	Ecotomografía obstétrica normal	examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Amnios confundido con piel.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL
p. 9
Tema 19.2

Clase 19.2 en video

03 TEMA 19.2 · ECOGRAFÍA OBSTÉTRICA

ECOGRAFÍA

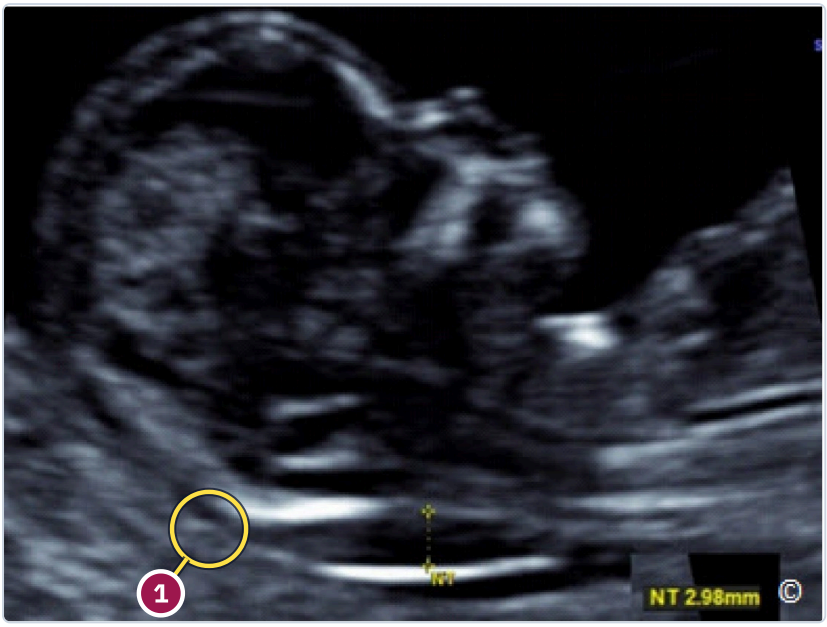


Imagen: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, p. 88

QUÉ TIENES QUE VER

1 TN

DIAGNÓSTICO

Translucencia nucal aumentada

Medición en corte sagital medio.

CONDUCTA INICIAL

TN aumentada: ofrecer estudio genético y ecocardiograma.

3.01.4.004 **Ecotomografía obstétrica patológica**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON...

Higroma quístico.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P50 «Una paciente de 32 años, con un embarazo de 12 semanas, se realiza una ecografía obstétrica que revela una translucencia nucal mayor al percentil...» → **Biopsia** ...

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL

p. 9

Tema 19.2

Clase 19.2 en video

04 TEMA 19.3 · EVALUACIÓN DEL BIENESTAR FETAL

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

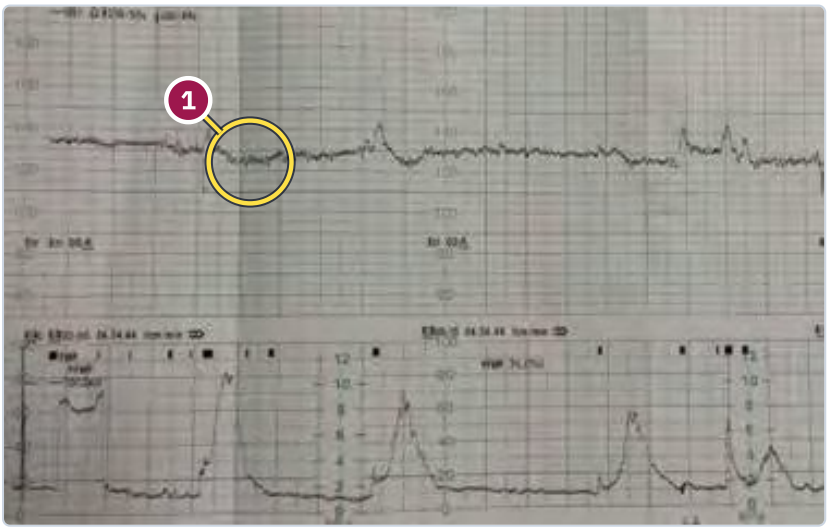


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 171

QUÉ TIENES QUE VER

1 Aceleraciones

DIAGNÓSTICO

Registro cardiotocográfico reactivo

Línea de base normal con aceleraciones.

CONDUCTA INICIAL

Reactivo: bienestar fetal.

3.01.5.009 **Monitorizacion fetal (estresante y no estresante)**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON...

No reactivo: perfil biofísico.

PREGUNTA REAL

Julio 2013 · P25 «Una mujer de 28 años, con embarazo de 30 semanas, consulta angustiada por no percibir movimientos fetales, sin otros síntomas. Su examen físico...» → **Repetir**...

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL

p. 13

Tema 19.3

Clase 19.3 en video

05 TEMA 19.3 · EVALUACIÓN DEL BIENESTAR FETAL

ESQUEMA

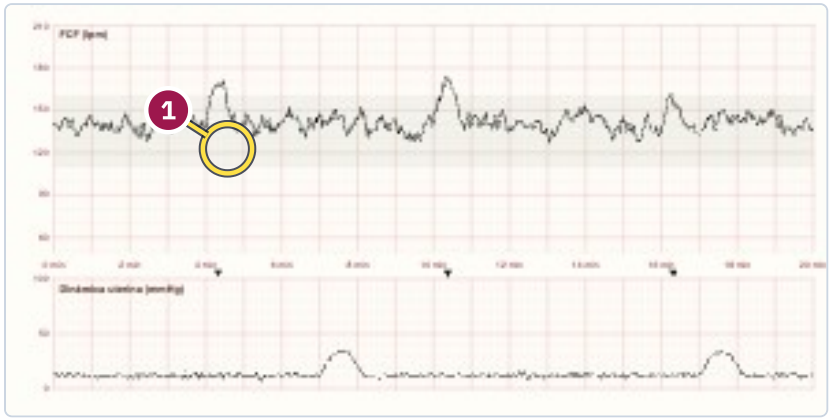


Imagen: Esquema EUNACOM 2026 · 20 minutos de registro

QUÉ TIENES QUE VER

1 Aceleraciones

DIAGNÓSTICO

Registro basal no estresante

FCF con aceleraciones y dinámica uterina.

CONDUCTA INICIAL

Dos aceleraciones en 20 min: reactivo.

3.01.5.009	Monitorizacion fetal (estresante y no estresante) — examen/procedimiento
3.01.5.005	Evaluación anteparto — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Desaceleraciones: requieren análisis.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2022 · P16 «Una paciente de 28 años, cursando su segundo embarazo de 35 semanas + 6 días, consulta por un cuadro de astenia, malestar general y aumento de…» → **Solicita**…

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL
p. 13
Tema 19.3

Clase 19.3 en video

06 TEMA 19.4 · RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO FETAL (RCF)

ECOGRAFÍA

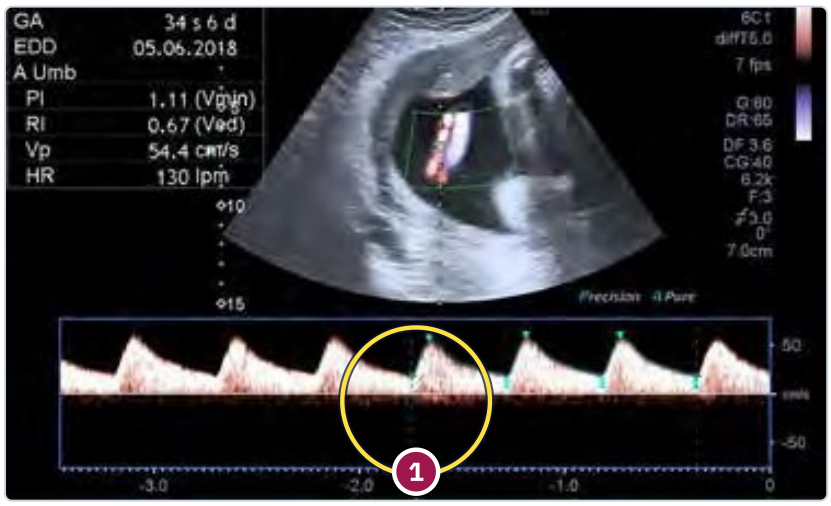


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 121

QUÉ TIENES QUE VER

1 Flujo diastólico

DIAGNÓSTICO

Doppler de arteria umbilical normal

Flujo diastólico conservado.

CONDUCTA INICIAL

RCF: seguimiento Doppler.

3.01.5.003	Doppler materno-fetal — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Diástole ausente.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL
p. 17
Tema 19.4

Clase 19.4 en video

07 TEMA 19.4 · RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO FETAL (RCF)

ECOGRAFÍA

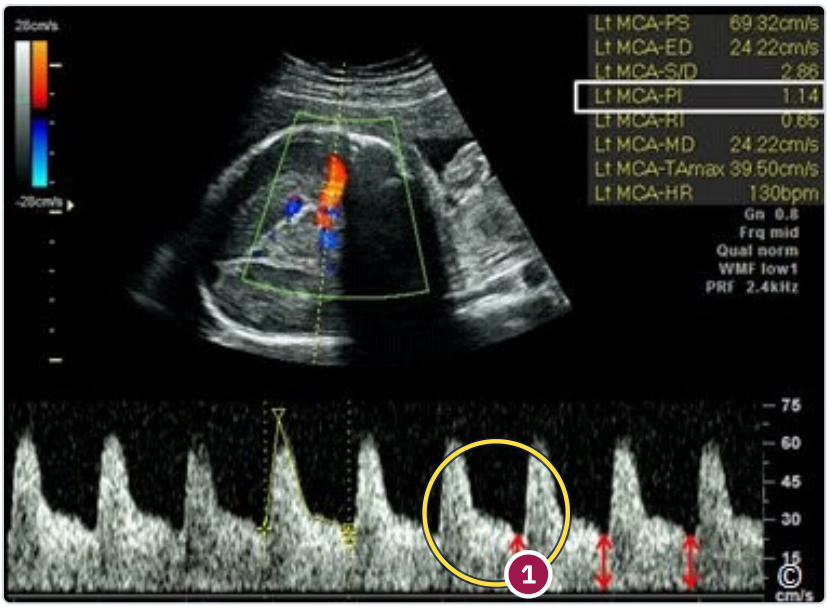


Imagen: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach, p. 129

QUÉ TIENES QUE VER

1 Flujo diastólico aumentado

DIAGNÓSTICO

Arteria cerebral media vasodilatada

Redistribución: el feto protege el cerebro.

CONDUCTA INICIAL

RCF con redistribución: control estrecho.

3.01.1.010 **Restricción de crecimiento fetal** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

3.01.5.003 **Doppler materno-fetal** — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

ACM normal.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2019 · P24** «Una paciente de 34 años, tiene un embarazo de 35 semanas, con feto creciendo en el percentil 2, desde la semana 33, con Doppler fetal normal, en…» → **Realiza**…

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL
p. 17
Tema 19.4

Clase 19.4 en video

08 TEMA 19.4 · RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO FETAL (RCF)

ECOGRAFÍA

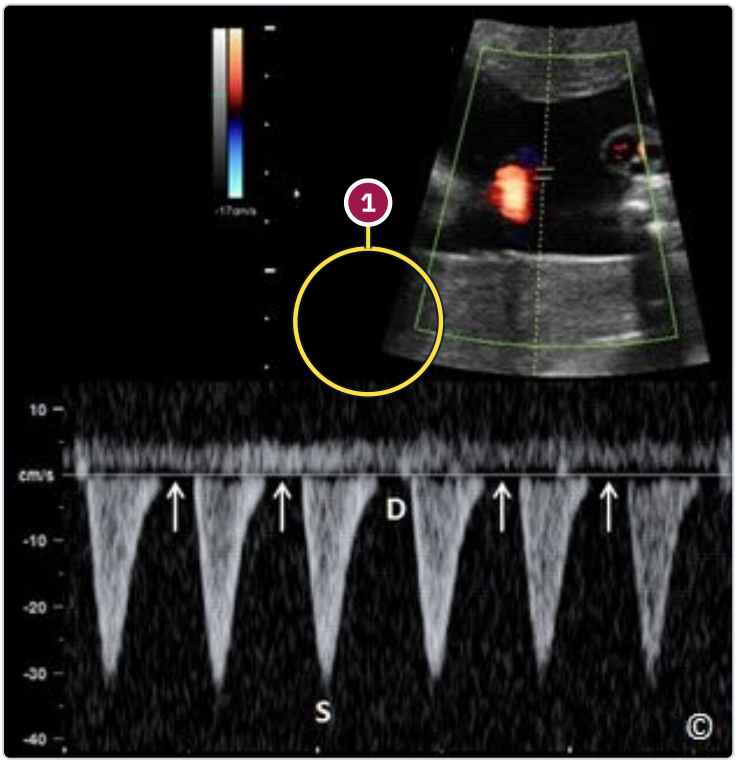


Imagen: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach, p. 127

QUÉ TIENES QUE VER

1 Diástole ausente

DIAGNÓSTICO

Flujo diastólico ausente

Sin flujo en diástole en la arteria umbilical (flechas).

CONDUCTA INICIAL

Interrupción según edad gestacional.

3.01.1.010 **Restricción de crecimiento fetal** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Doppler normal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL
p. 16
Tema 19.4

Clase 19.4 en video

09 TEMA 19.4 · RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO FETAL (RCF)

ECOGRAFÍA

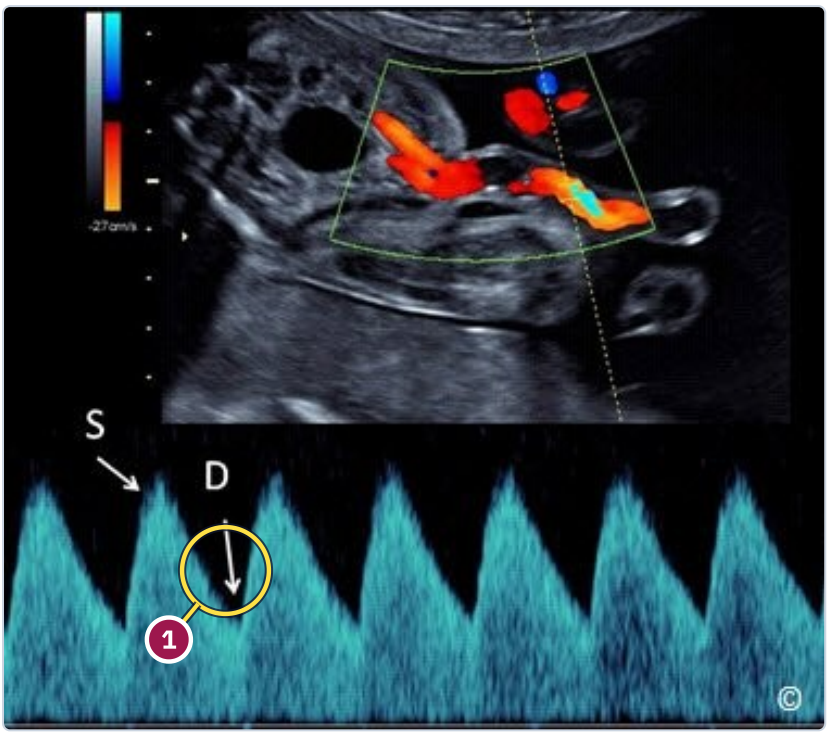


Imagen: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach, p. 126

QUÉ TIENES QUE VER

1 Diástole

DIAGNÓSTICO

Doppler umbilical alterado

Sístole (S) y diástole (D) en la umbilical.

CONDUCTA INICIAL

Diástole reversa: interrupción.

3.01.1.010 Restricción de crecimiento fetal — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Normal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL **p. 16** Tema 19.4

Clase 19.4 en video

10 TEMA 19.4 · RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO FETAL (RCF)

ECOGRAFÍA

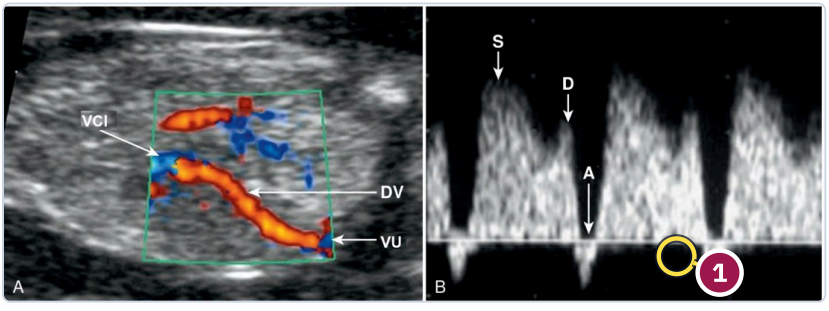


Imagen: Rumack, Diagnostic Ultrasound, 4.ª ed., p. 1128

QUÉ TIENES QUE VER

1 Onda a

DIAGNÓSTICO

Ductus venoso con onda a reversa

Onda a invertida: descompensación cardíaca fetal.

CONDUCTA INICIAL

Indica interrupción del embarazo.

3.01.1.010 Restricción de crecimiento fetal — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

3.01.5.003 Doppler materno-fetal — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Ductus normal: onda a positiva.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL **p. 16** Tema 19.4

Clase 19.4 en video

11 TEMA 19.4 · RESTRICCIÓN DEL CRECIMIENTO FETAL (RCF)

ECOGRAFÍA

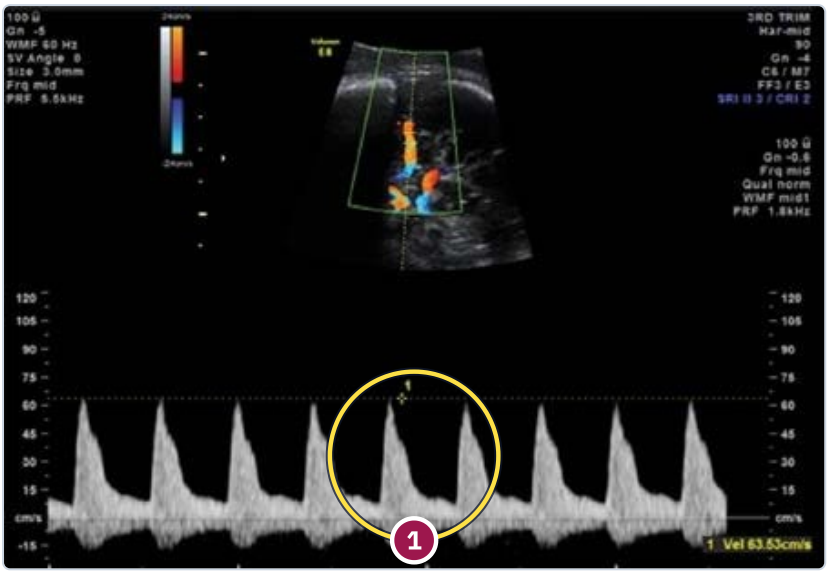


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22nd ed., p. 1437

QUÉ TIENES QUE VER

1 Onda de la ACM

DIAGNÓSTICO

Doppler de arteria cerebral media

Velocidad sistólica máxima.

CONDUCTA INICIAL

VSM > 1,5 MoM: anemia fetal.

3.01.5.003 **Doppler materno-fetal** — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Normal.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL **p. 15** Tema 19.4

Clase 19.4 en video

12 TEMA 19.7 · DIABETES GESTACIONAL Y PREGESTACIONAL

ECOGRAFÍA

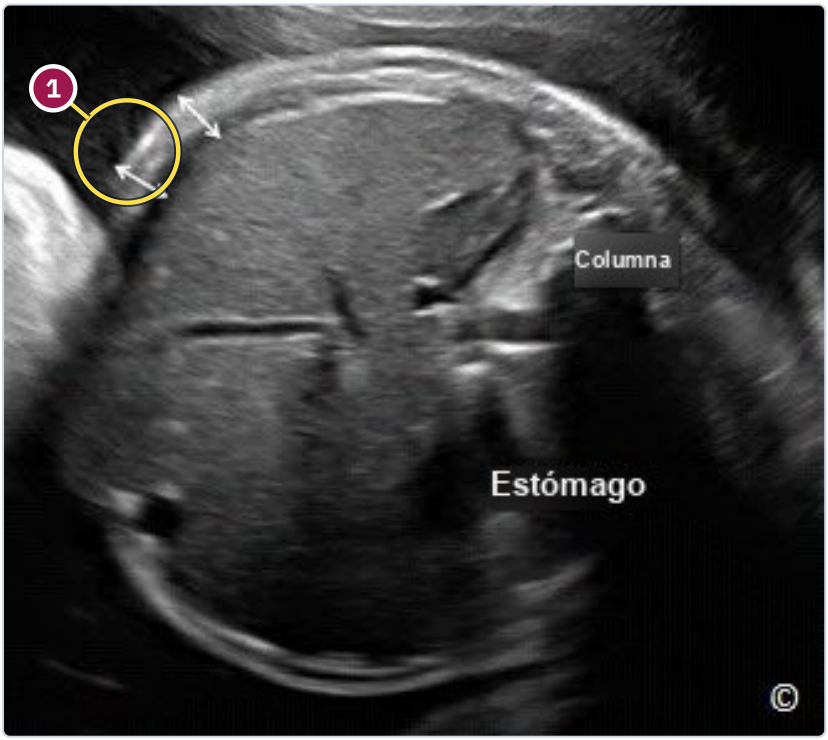


Imagen: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach, Fig. 6.10

QUÉ TIENES QUE VER

1 Grasa subcutánea

DIAGNÓSTICO

Macrosomía: grasa subcutánea aumentada

Grasa abdominal gruesa (flechas).

CONDUCTA INICIAL

Diabetes: control glicémico; cesárea si > 4.500 g.

3.01.1.009 **Macrosomía fetal** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

3.01.1.004 **Diabetes y embarazo** — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Error de medición.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2024 · P97** «Embarazada de 38 semanas con feto estimado de 4.300 g y cesárea previa por desproporción cefalopélvica, cuyo hijo pesó 3.900 g. ¿Cuál es la conducta?» →…

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL **p. 32** Tema 19.7

Clase 19.7 en video

13 TEMA 19.21 · CARDIOPATÍA, EMBARAZO MÚLTIPLE E HIPEREMESIS GRAVÍDICA

ESQUEMA

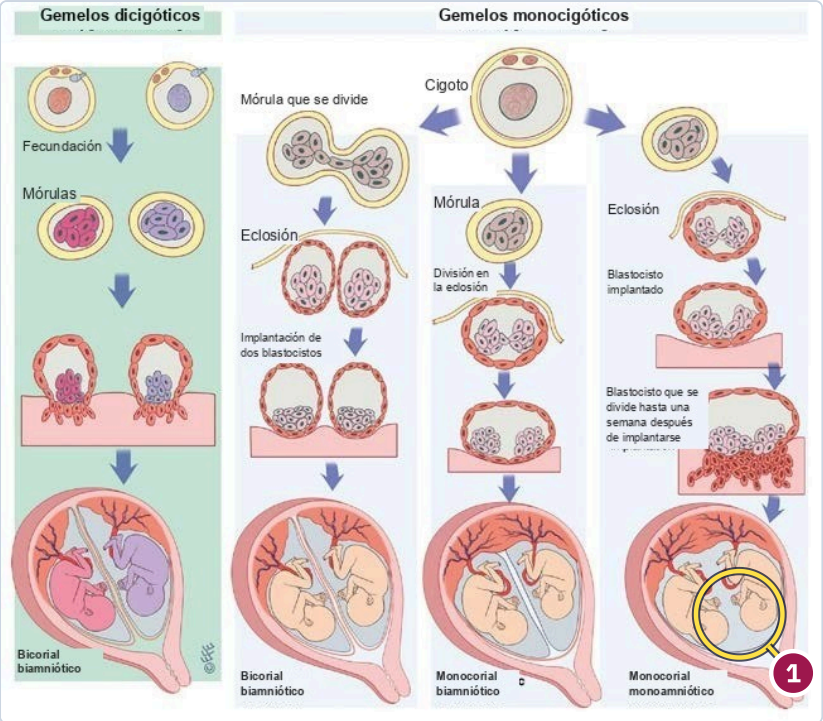


Imagen: Nelson 22.ª ed., p. 1320

QUÉ TIENES QUE VER

1 Monocorial monoamniótico

DIAGNÓSTICO

Corionicidad y amnionicidad

Según el momento de división del cigoto.

CONDUCTA INICIAL

Determinar corionicidad en el primer trimestre.

3.01.1.007 **Embarazo múltiple**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Dicigóticos: siempre bicoriales.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL **p. 44** Tema 19.21

Clase 19.21 en video

14 TEMA 19.21 · CARDIOPATÍA, EMBARAZO MÚLTIPLE E HIPEREMESIS GRAVÍDICA

ECOGRAFÍA

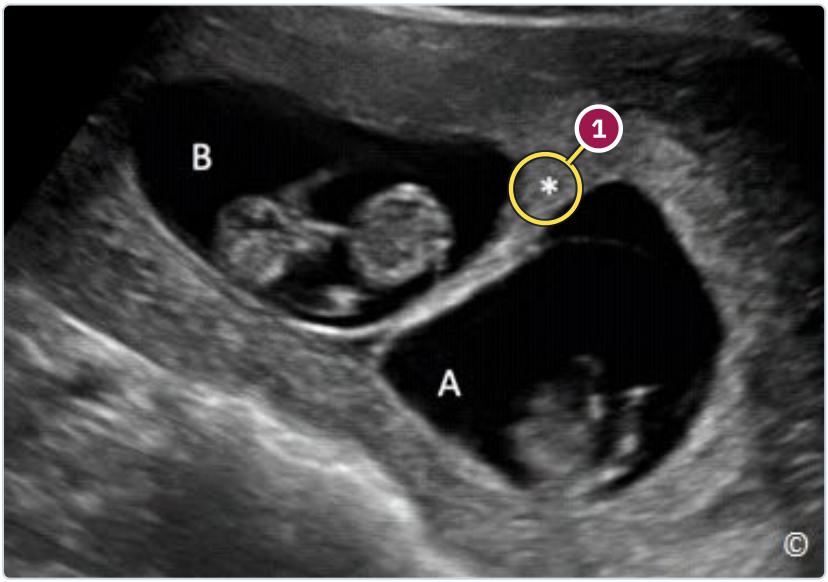


Imagen: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach, Fig. 7.2

QUÉ TIENES QUE VER

1 Signo lambda

DIAGNÓSTICO

Signo lambda: bicorial

Placenta que entra entre las membranas (*).

CONDUCTA INICIAL

Bicorial: menor riesgo.

3.01.1.007 **Embarazo múltiple**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Signo T: monocorial.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P59** «Una paciente de 39 años, cursando un embarazo gemelar bicorial biamniótico de 36 semanas, acude a control. Se encuentra en buenas condiciones…» → **Realizar**…

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL **p. 44** Tema 19.21

Clase 19.21 en video

15 TEMA 19.21 · CARDIOPATÍA, EMBARAZO MÚLTIPLE E HIPEREMESIS GRAVÍDICA

ECOGRAFÍA

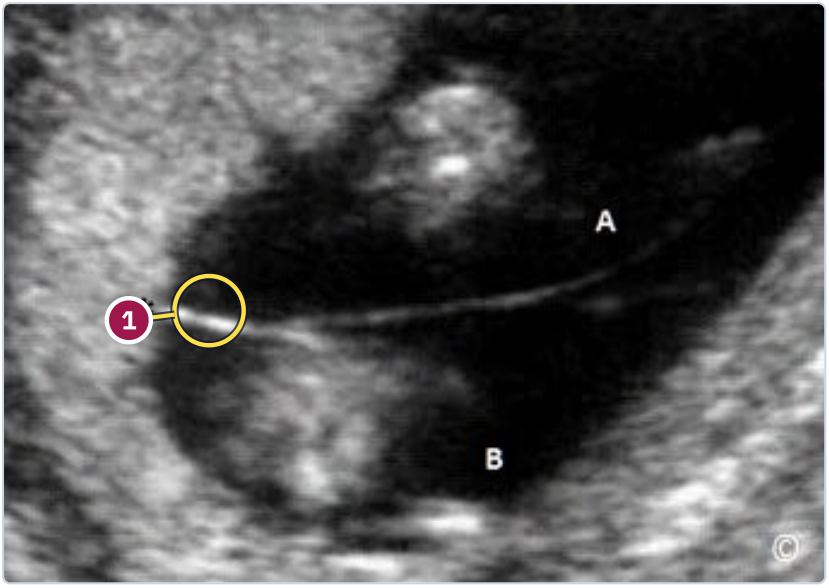


Imagen: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach, Fig. 4.20

QUÉ TIENES QUE VER

1. Membrana fina

DIAGNÓSTICO

Monocorial: membrana fina

Membrana delgada en T (*).

CONDUCTA INICIAL

Monocorial: control cada 2 semanas por transfusión feto-fetal.

3.01.1.007 Embarazo múltiple

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Bicorial.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL
p. 44
Tema 19.21

Clase 19.21 en video

16 TEMA 19.21 · CARDIOPATÍA, EMBARAZO MÚLTIPLE E HIPEREMESIS GRAVÍDICA

ECOGRAFÍA

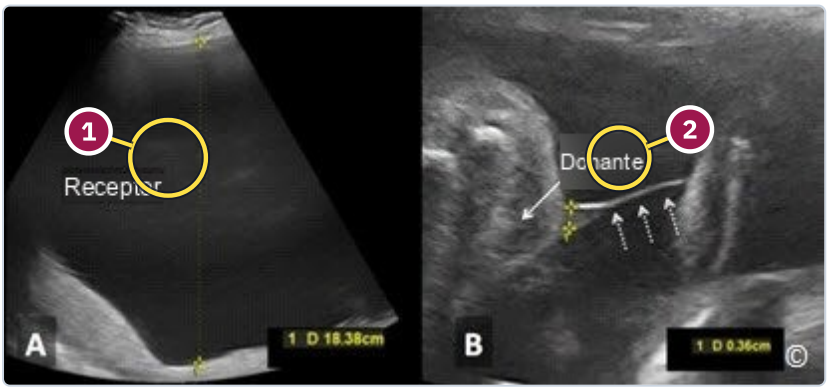


Imagen: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach, p. 143

QUÉ TIENES QUE VER

1. Receptor
2. Donante

DIAGNÓSTICO

Transfusión feto-fetal

Receptor con polihidramnios; donante con oligohidramnios.

CONDUCTA INICIAL

Láser fetoscópico.

3.01.1.007 Embarazo múltiple

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

RCF selectivo.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL
p. 45
Tema 19.21

Clase 19.21 en video

17 TEMA 19.10 · ABORTO ESPONTÁNEO, FORMAS CLÍNICAS, ABORTO SÉPTICO Y LEY IVE 21.030

ECOGRAFÍA

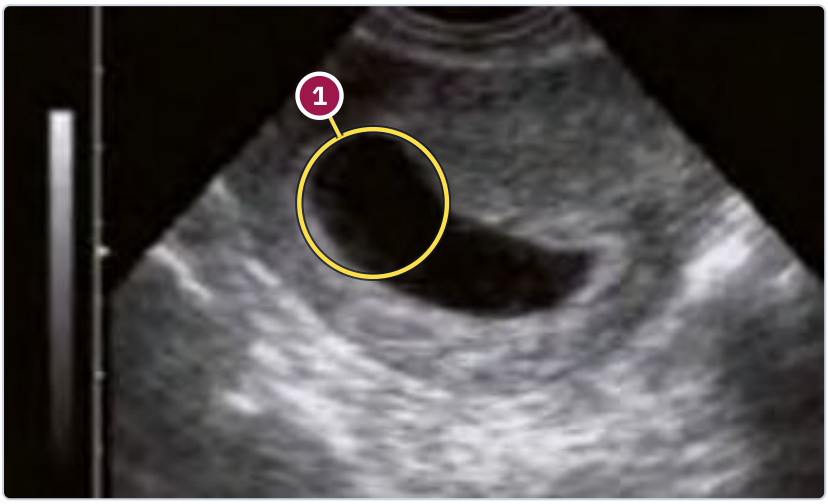


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 124

QUÉ TIENES QUE VER

1 Saco

DIAGNÓSTICO

Gestación interrumpida

Saco sin embrión o embrión sin latido.

CONDUCTA INICIAL

Aborto retenido: misoprostol o aspiración.

3.01.1.001 **Aborto espontáneo**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Embarazo muy precoz: repetir.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P97 «Una paciente de 21 años consulta por fiebre hasta 38,9 °C asociada a dolor hipogástrico intenso y sangrado vaginal de mal olor, que inició hace…» → **Administra**…

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL

p. 50

Tema 19.10

Clase 19.10 en video

18 TEMA 19.10 · ABORTO ESPONTÁNEO, FORMAS CLÍNICAS, ABORTO SÉPTICO Y LEY IVE 21.030

ECOGRAFÍA

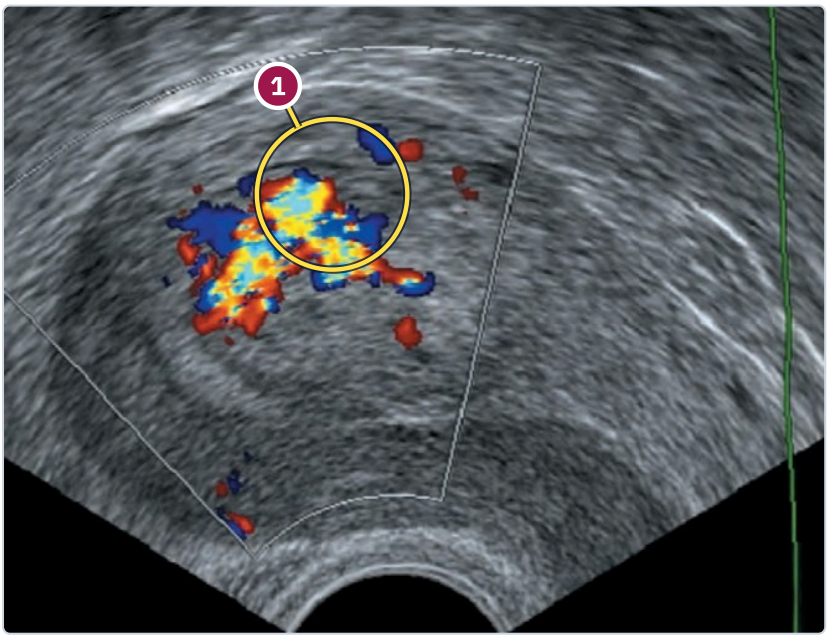


Imagen: Diagnostic Ultrasound (Rumack), p. 1116

QUÉ TIENES QUE VER

1 Restos

DIAGNÓSTICO

Restos ovulares con Doppler

Material vascularizado en la cavidad.

CONDUCTA INICIAL

Aborto incompleto: evacuación.

3.01.1.001 **Aborto espontáneo**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Coágulos: sin flujo.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL

p. 51

Tema 19.10

Clase 19.10 en video

19 TEMA 19.10 · ABORTO ESPONTÁNEO, FORMAS CLÍNICAS, ABORTO SÉPTICO Y LEY IVE 21.030

PIEZA ANATÓMICA

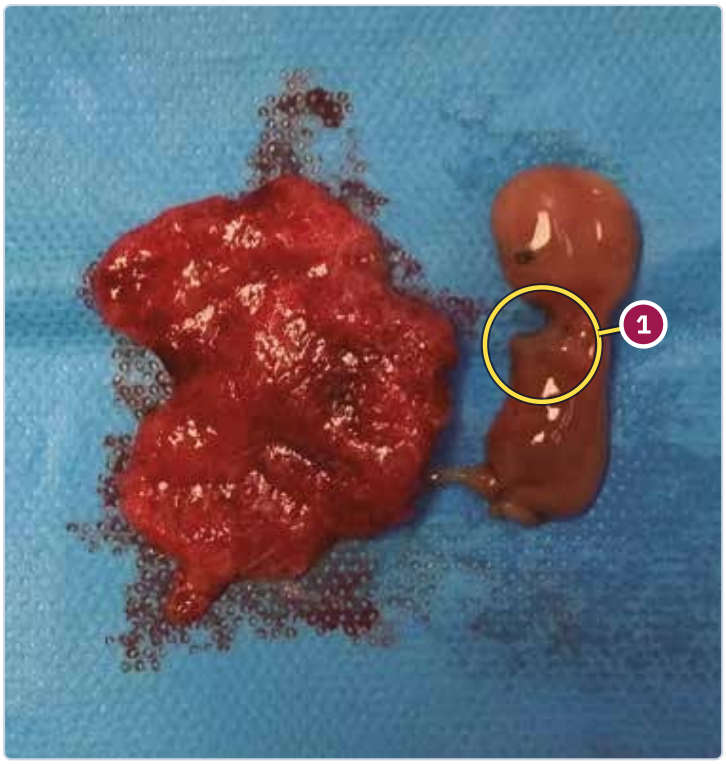


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 123

QUÉ TIENES QUE VER

1 Embrión

DIAGNÓSTICO

Embrión y restos expulsados

Aborto precoz.

CONDUCTA INICIAL

Completo: control; Rh negativo: anti-D.

3.01.1.001 **Aborto espontáneo**

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Coágulos.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL **p. 51** Tema 19.10

Clase 19.10 en video

20 TEMA 19.11 · EMBARAZO ECTÓPICO

ECOGRAFÍA

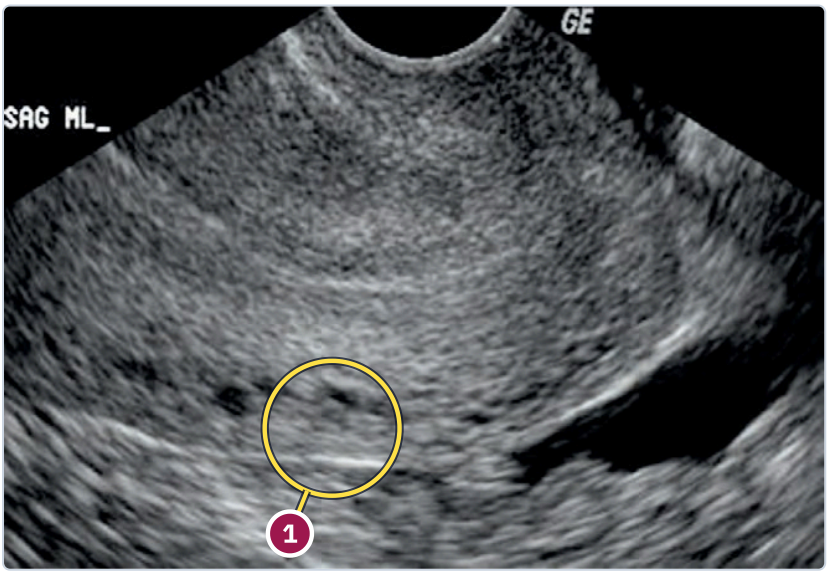


Imagen: Diagnostic Ultrasound (Rumack), p. 1121

QUÉ TIENES QUE VER

1 Líquido libre

DIAGNÓSTICO

Líquido libre en el Douglas

Hemoperitoneo.

CONDUCTA INICIAL

Ectópico roto con shock: cirugía.

3.01.2.005 **Embarazo ectópico complicado**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Líquido fisiológico.

PREGUNTA REAL **Enero 2023 · P62** «Mujer joven con dolor súbito en FID, hipotensión y taquicardia súbitas, dolor en ambas fosas ilíacas. ¿Diagnóstico más probable?» → **Embarazo ectópico roto**

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL **p. 56** Tema 19.11

Clase 19.11 en video

21 TEMA 19.11 · EMBARAZO ECTÓPICO

ECOGRAFÍA

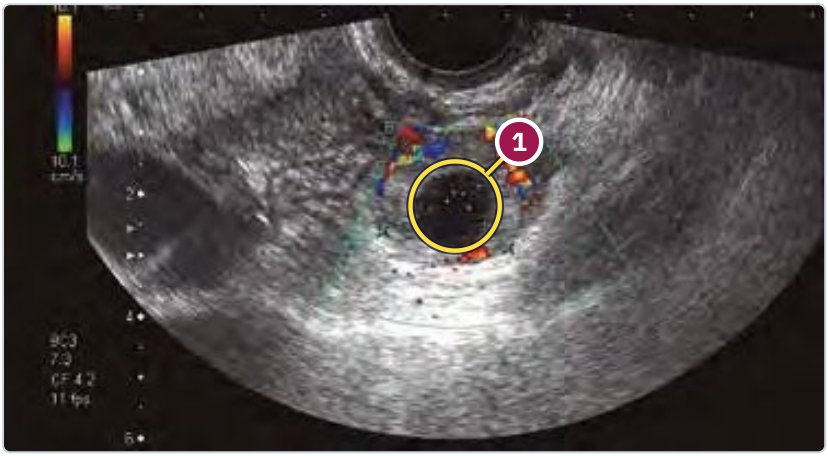


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 126

QUÉ TIENES QUE VER

1 Masa anexial

DIAGNÓSTICO

Embarazo ectópico ampular

Masa anexial con anillo vascular.

CONDUCTA INICIAL

Estable, β-hCG < 5.000 y masa < 3,5 cm: metotrexato.

3.01.1.006 Embarazo ectópico no complicado — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

3.01.4.008 HCG cuantitativa — examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Cuerpo lúteo.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P29** «Una paciente de 24 años presenta amenorrea de 7 semanas de evolución, por lo que consulta. Su examen físico muestra FC: 80x', PA: 120/80 mmHg,…» → **Indicar**…

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL **p. 56** Tema 19.11

Clase 19.11 en video

22 TEMA 19.11 · EMBARAZO ECTÓPICO

ESQUEMA



Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 126

QUÉ TIENES QUE VER

1 β-hCG < 1.800

DIAGNÓSTICO

Útero vacío y β-hCG

Algoritmo según β-hCG y su curva en 48 h.

CONDUCTA INICIAL

Sobre zona de discriminación sin saco: ectópico.

3.01.4.008 HCG cuantitativa — examen/procedimiento

3.01.1.006 Embarazo ectópico no complicado — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Aborto completo: β-hCG baja.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL **p. 56** Tema 19.11

Clase 19.11 en video

23 TEMA 19.12 · ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL

ECOGRAFÍA

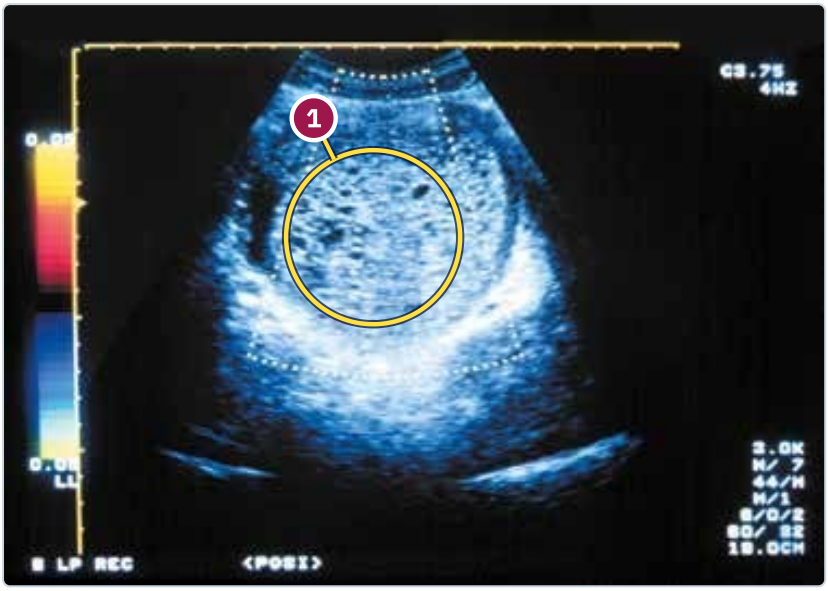


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 129

QUÉ TIENES QUE VER

1 Patrón vesicular

DIAGNÓSTICO

Mola completa: tormenta de nieve

Útero lleno de ecos sin embrión.

CONDUCTA INICIAL

Aspiración y seguimiento con β-hCG.

3.01.1.008 Enfermedad del trofoblasto

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Aborto retenido.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P82 «Una paciente de 25 años acude al servicio de urgencia por metrorragia abundante de 2 días de evolución. Tiene antecedente de atraso menstrual de…» → **Mol**…

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL

p. 62

Tema 19.12

Clase 19.12 en video

24 TEMA 19.12 · ENFERMEDAD TROFOBLÁSTICA GESTACIONAL

ECOGRAFÍA

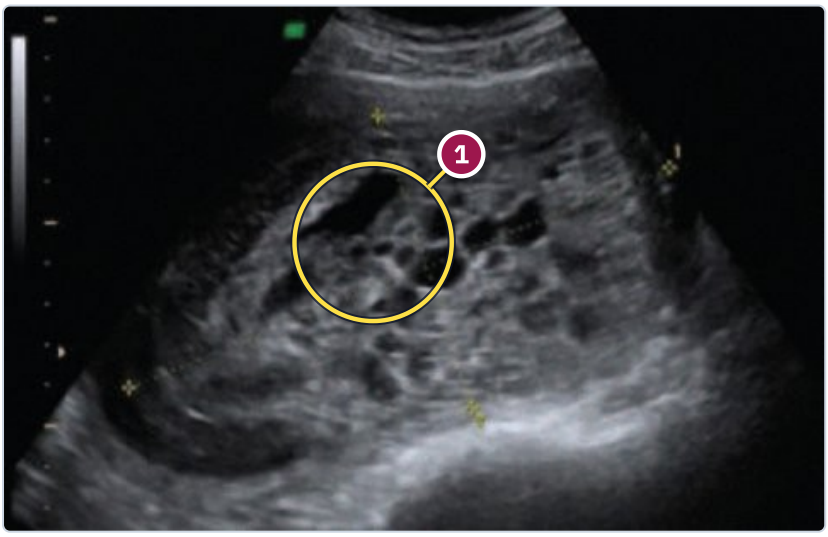


Imagen: Manual AMIR Ginecología y Obstetricia, p. 33

QUÉ TIENES QUE VER

1 Vesículas

DIAGNÓSTICO

Mola: vesículas sin embrión

Múltiples vesículas pequeñas.

CONDUCTA INICIAL

Anticoncepción durante el seguimiento.

3.01.1.008 Enfermedad del trofoblasto

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Degeneración hidrópica.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL

p. 62

Tema 19.12

Clase 19.12 en video

25 TEMA 19.13 · METRORRAGIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

ECOGRAFÍA

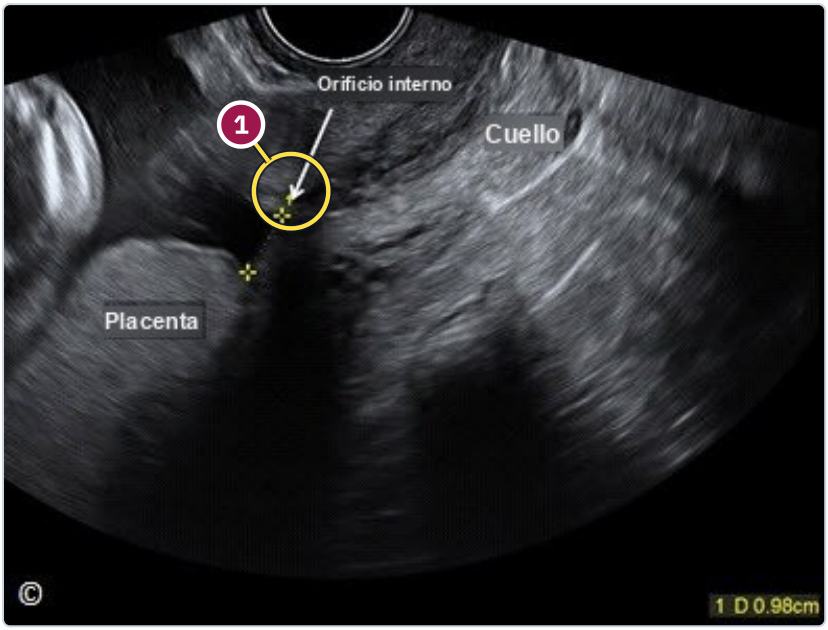


Imagen: Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: A Practical Approach, p. 157

QUÉ TIENES QUE VER

1 Orificio interno

DIAGNÓSTICO

Placenta previa en la ecografía transvaginal

Placenta que llega al orificio interno.

CONDUCTA INICIAL

No hacer tacto vaginal.

3.01.2.011 **Metrorragia: placenta previa**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Placenta baja.

PREGUNTA REAL **Julio 2016 · P40** «Una paciente multípara, con un parto anterior por cesárea, cursando con un nuevo embarazo de 35 semanas, consulta por metrorragia moderada. Al…» → **Realizar cesárea**

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL **p. 67** Tema 19.13

Clase 19.13 en video

26 TEMA 19.13 · METRORRAGIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

ESQUEMA



Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 DPPNI

DIAGNÓSTICO

Placenta previa vs DPPNI

Dónde está la placenta.

CONDUCTA INICIAL

DPPNI: dolor, útero duro, sangre oscura.

3.01.2.010 **Metrorragia: Desprendimiento previo de placenta normoinserta (DPPNI)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

3.01.2.011 **Metrorragia: placenta previa**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Previa: indolora, sangre roja.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2025 · P49** «Una paciente de 33 años, cursando un embarazo de 36 semanas, consulta por contracciones uterinas dolorosas y metrorragia. Al examen se palpa un…» → **Realizar**…

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL **p. 67** Tema 19.13

Clase 19.13 en video

27 TEMA 19.13 · METRORRAGIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

ESQUEMA

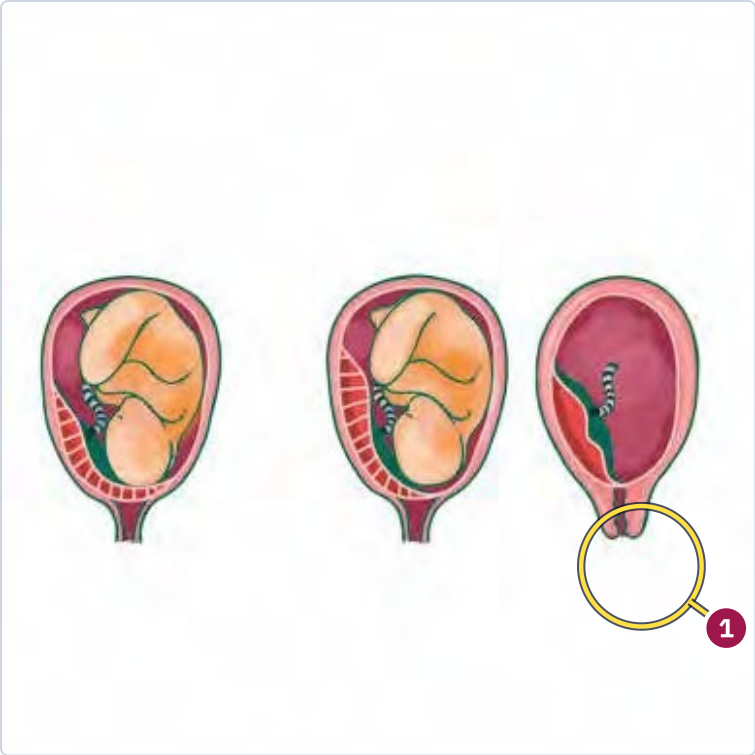


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 133

QUÉ TIENES QUE VER

1 Oclusiva

DIAGNÓSTICO

Tipos de placenta previa

Oclusiva total, parcial y marginal.

CONDUCTA INICIAL

Oclusiva: cesárea.

3.01.2.011 Metrorragia: placenta previa — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Normoinserta.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL p. 67 Tema 19.13

Clase 19.13 en video

28 TEMA 19.13 · METRORRAGIAS DE LA SEGUNDA MITAD DEL EMBARAZO

ECOGRAFÍA

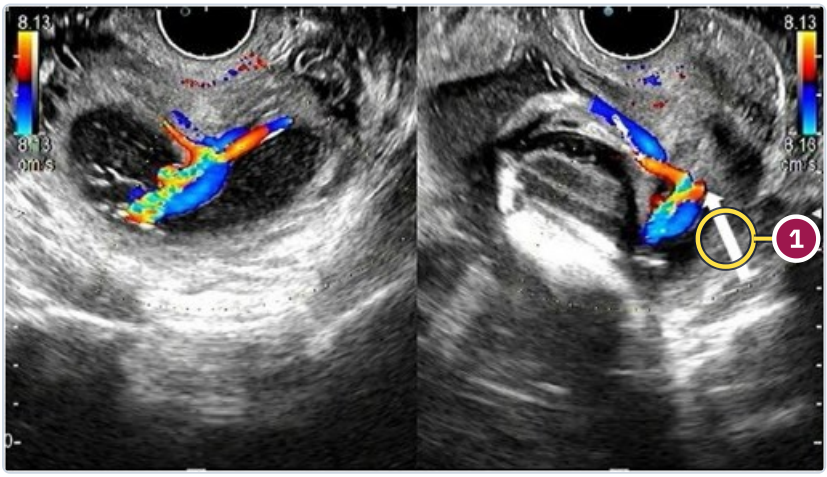


Imagen: Open-i (NLM), CC BY

QUÉ TIENES QUE VER

1 Vasos

DIAGNÓSTICO

Vasa previa

Vasos fetales sobre el orificio cervical (flecha).

CONDUCTA INICIAL

Cesárea electiva a las 34–36 semanas.

3.01.2.011 Metrorragia: placenta previa — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cordón libre.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL p. 65 Tema 19.13

Clase 19.13 en video

29 TEMA 19.14 · ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS (RPM), LATENCIA, PROFILAXIS ANTIBIÓTICA Y CORIOAMNIONITIS

HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA

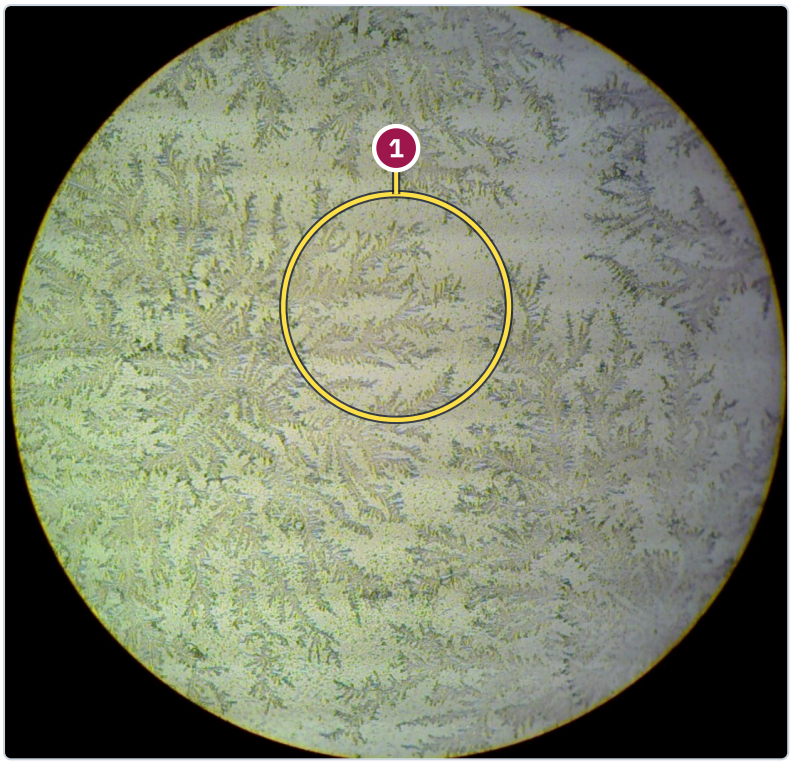


Imagen: Wikimedia Commons «Positive Fern Test.jpg», CC BY-SA 2.0, ver autor en Commons

QUÉ TIENES QUE VER

1 Patrón en helecho

DIAGNÓSTICO

Test de helecho

Cristalización del líquido amniótico.

CONDUCTA INICIAL

Confirma la RPM.

3.01.2.014 Rotura prematura de membranas

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Moco cervical.

PREGUNTA REAL **Julio 2025 · P85** «Embarazada de 35 semanas con rotura prematura de membranas hace 48 horas. Sin contracciones, sin fiebre, sin signos de infección. Feto en…» → **Inducción del par…**

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL
p. 76
Tema 19.14

Clase 19.14 en video

30 TEMA 19.15 · SÍNDROME DE PARTO PREMATURO

ECOGRAFÍA

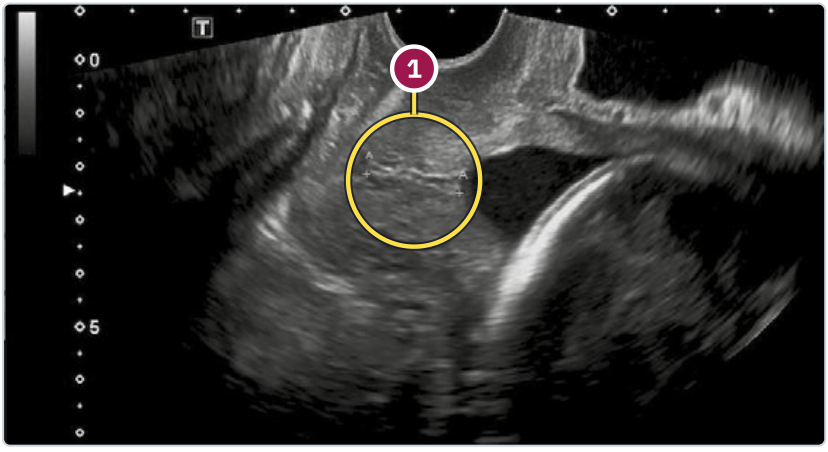


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 159

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cuello

DIAGNÓSTICO

Cervicometría

Longitud cervical por ecografía transvaginal.

CONDUCTA INICIAL

< 25 mm: progesterona.

3.01.2.012 Parto prematuro

Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

SE CONFUNDE CON…

Cuello normal.

PREGUNTA REAL **Julio 2024 · P72** «Una paciente de 27 años, cursando un embarazo de 32 semanas consulta en urgencias por contracciones uterinas dolorosas. Al examen físico se…» →…

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL
p. 80
Tema 19.15

Clase 19.15 en video

31 TEMA 19.16 · TRABAJO DE PARTO NORMAL, MECANISMOS DEL PARTO EN CEFÁLICA, SCORE DE BISHOP Y MANEJO ACTIVO DEL ALUMBRAMIENTO

ESQUEMA

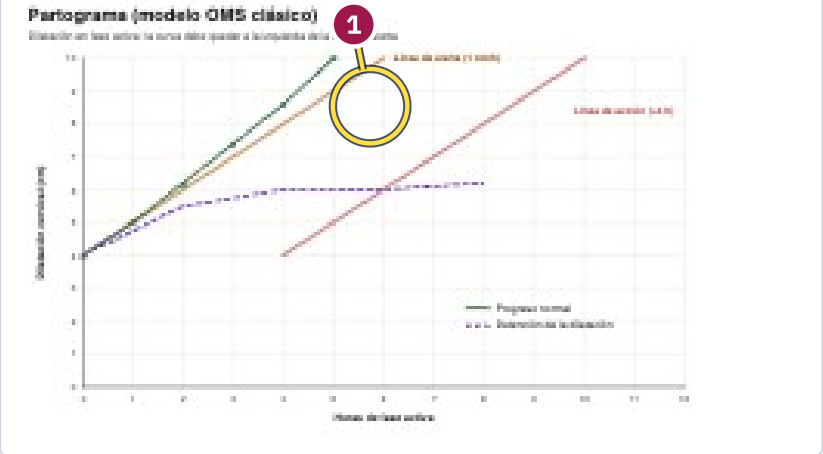


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Línea de alerta

DIAGNÓSTICO

Partograma

Líneas de alerta y de acción.

CONDUCTA INICIAL

Cruza la línea de acción: evaluar distocia.

3.01.5.010 Parto normal

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Fase latente.

PREGUNTA REAL

Julio 2013 · P134 «Embarazada de 37 semanas, primigesta, presenta contracciones uterinas desde hace dos horas, no asociado a otros síntomas. Al examen físico se…» → **Conducir**…

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL

p. 87

Tema 19.16

Clase 19.16 en video

32 TEMA 19.16 · TRABAJO DE PARTO NORMAL, MECANISMOS DEL PARTO EN CEFÁLICA, SCORE DE BISHOP Y MANEJO ACTIVO DEL ALUMBRAMIENTO

ESQUEMA

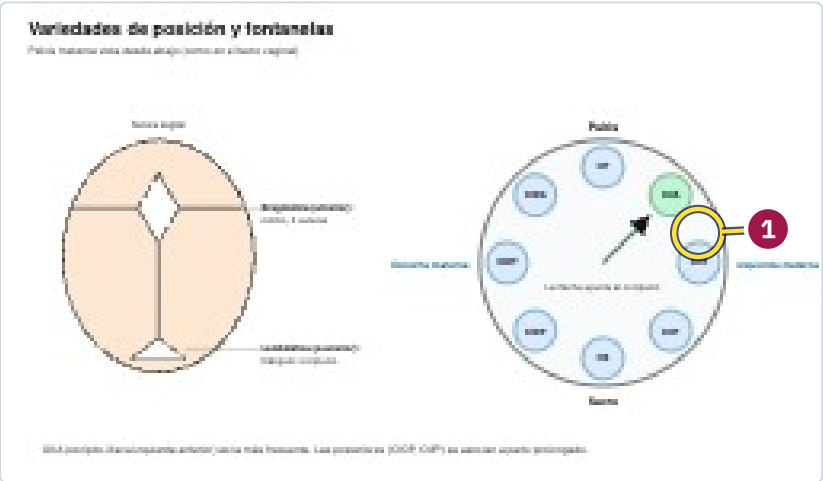


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 OIIA

DIAGNÓSTICO

Variedades de posición

OIIA es la más frecuente.

CONDUCTA INICIAL

Posteriores: parto prolongado.

3.01.5.010 Parto normal

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Presentación podálica.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL

p. 87

Tema 19.16

Clase 19.16 en video

33 TEMA 19.17 · DISTOCIAS DEL TRABAJO DE PARTO, DISTOCIA DE HOMBROS Y MONITORIZACIÓN INTRAPARTO (CTG FIGO)

FOTO CLÍNICA

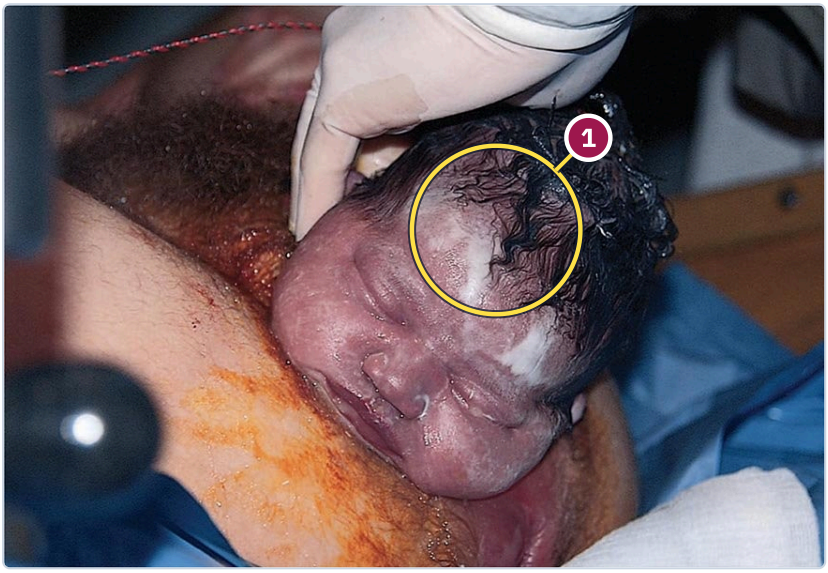


Imagen: The Atlas of Emergency Medicine (Knoop), p. 292

QUÉ TIENES QUE VER

1 Cabeza retraída

DIAGNÓSTICO

Signo de la tortuga

La cabeza se retrae contra el periné.

CONDUCTA INICIAL

Distocia de hombros: McRoberts y presión suprapúbica.

3.01.2.021 Trabajo parto distócico

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Expulsivo prolongado.

PREGUNTA REAL

Diciembre 2025 · P105 «Una paciente de 30 años, mul` para de uno, con antecedente de parto vaginal de recién nacido de 4.000 gramos, cursa nuevo embarazo de término con…» → **Distocia** …

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL

p. 89

Tema 19.17

Clase 19.17 en video

34 TEMA 19.17 · DISTOCIAS DEL TRABAJO DE PARTO, DISTOCIA DE HOMBROS Y MONITORIZACIÓN INTRAPARTO (CTG FIGO)

ESQUEMA

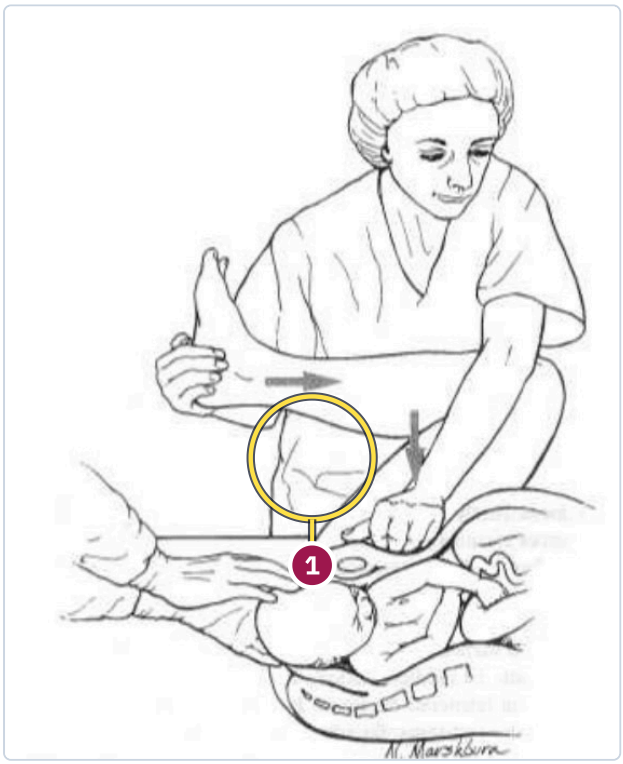


Imagen: Williams Obstetricia (ed. en español), Fig. 20-14, p. 515

QUÉ TIENES QUE VER

1 Presión suprapúbica

DIAGNÓSTICO

McRoberts y presión suprapúbica

Flexión de muslos y presión sobre el hombro.

CONDUCTA INICIAL

No traccionar la cabeza.

3.01.2.021 Trabajo parto distócico

Dx Sospecha | Tx Inicial | Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Fundal: contraindicada.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL

p. 90

Tema 19.17

Clase 19.17 en video

35 TEMA 19.17 · DISTOCIAS DEL TRABAJO DE PARTO, DISTOCIA DE HOMBROS Y MONITORIZACIÓN INTRAPARTO (CTG FIGO)

TRAZADO (ECG / REGISTRO)

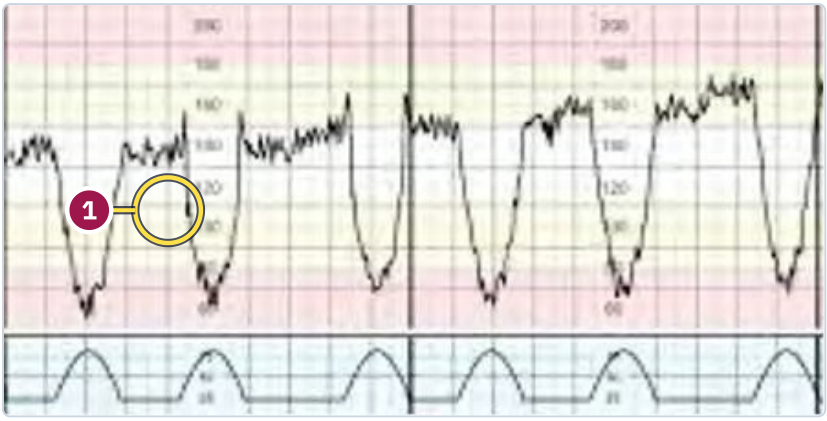


Imagen: Manual CTO Ginecología y Obstetricia 14.ª ed., p. 173

QUÉ TIENES QUE VER

1 Desaceleración

DIAGNÓSTICO

Desaceleraciones precoces

Espejo de la contracción.

CONDUCTA INICIAL

Benignas: compresión cefálica.

3.01.5.006 Evaluación intraparto — examen/procedimiento

3.01.2.017 Sufrimiento fetal agudo — Dx Específico · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Tardías: hipoxia.

PREGUNTA REAL

Julio 2024 · P22 «Una mujer de 38 de años, cursando un embarazo de término, inicia trabajo de parto. Actualmente tiene 7 cm de dilatación y se palpa la cabeza…» → **Realizar operaci**…

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL
p. 90
Tema 19.17

Clase 19.17 en video

36 TEMA 19.18 · HEMORRAGIA POSTPARTO INMEDIATA (HPI), CÓDIGO ROJO, REGLA DE LAS 4T Y ALGORITMO TERAPÉUTICO ESCALONADO

ESQUEMA

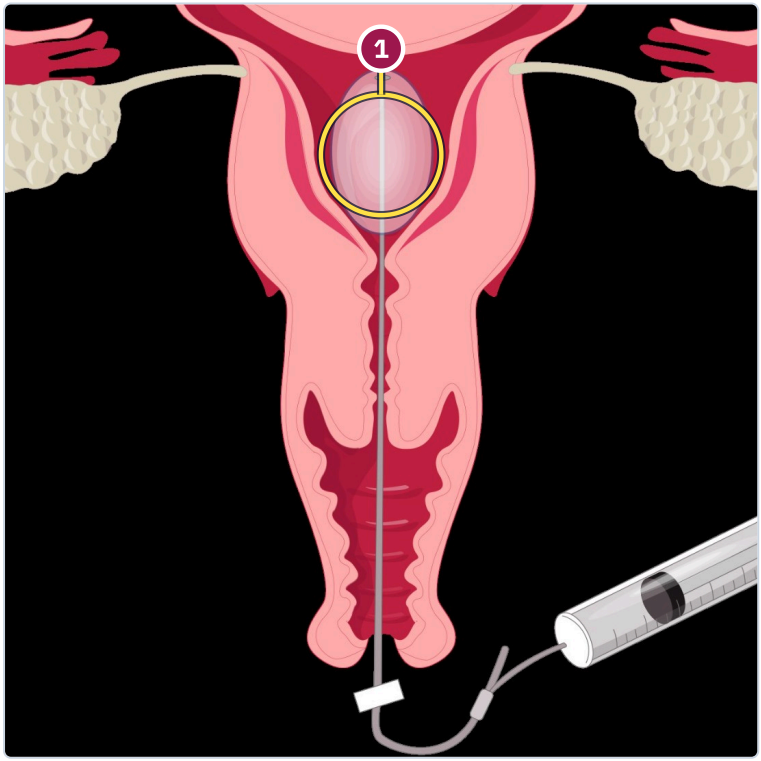


Imagen: Wikimedia Commons «Bakri Balloon Hariadhi.svg», CC BY-SA 4.0, Hariadhi

QUÉ TIENES QUE VER

1 Balón

DIAGNÓSTICO

Balón de Bakri

Taponamiento intrauterino.

CONDUCTA INICIAL

HPP que no cede con uterotónicos.

3.01.2.008 Hemorragia genital aguda (metrorragia disfuncional-cervicorragia por Cáncer C.U.) — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Histerectomía: último recurso.

PREGUNTA REAL

Julio 2025 · P122 «Mujer de 55 años postmenopáusica con miomas uterinos conocidos. Llega a urgencias por metrorragia severa con hipotensión 90/60 mmHg y FC 118 lpm….» →…

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL
p. 95
Tema 19.18

Clase 19.18 en video

37 TEMA 19.18 · HEMORRAGIA POSTPARTO INMEDIATA (HPI), CÓDIGO ROJO, REGLA DE LAS 4T Y ALGORITMO TERAPÉUTICO ESCALONADO

ESQUEMA

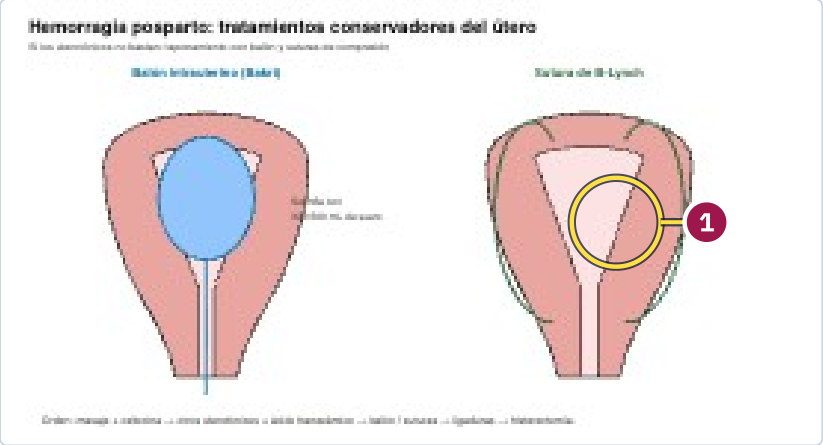


Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 B-Lynch

DIAGNÓSTICO

Balón de Bakri y sutura de B-Lynch

Tratamientos conservadores del útero.

CONDUCTA INICIAL

Masaje → uterotónicos → balón → suturas → ligaduras → histerectomía.

3.01.2.008 **Hemorragia genital aguda (metrorragia disfuncional-cervicorragia por Cáncer C.U.)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Atonía vs retención.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL **p. 95** Tema 19.18

Clase 19.18 en video

38 TEMA 19.18 · HEMORRAGIA POSTPARTO INMEDIATA (HPI), CÓDIGO ROJO, REGLA DE LAS 4T Y ALGORITMO TERAPÉUTICO ESCALONADO

FOTO CLÍNICA

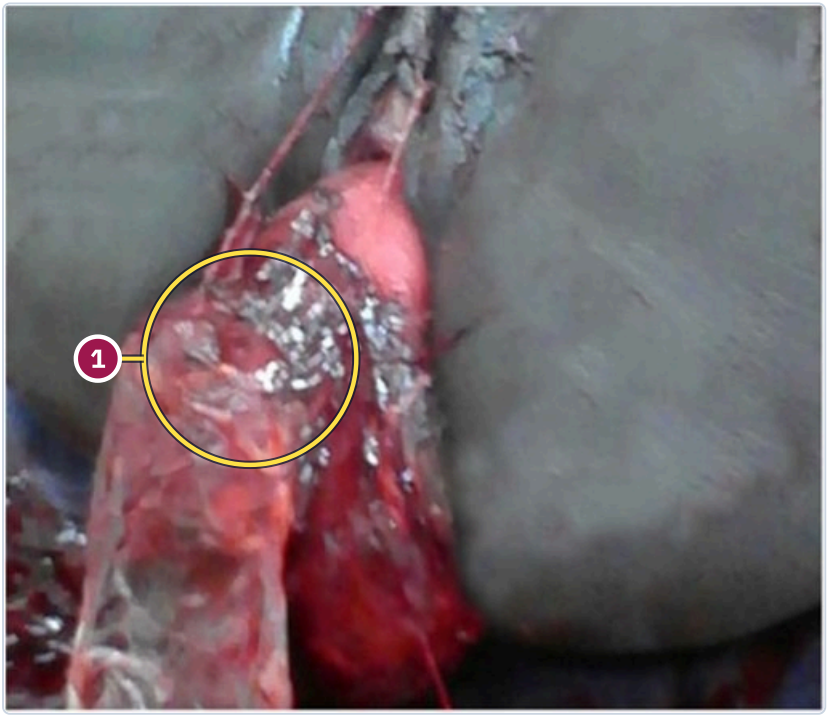


Imagen: Open-i (NLM), CC BY

QUÉ TIENES QUE VER

1 Útero invertido

DIAGNÓSTICO

Inversión uterina

Fondo uterino que sale por la vagina.

CONDUCTA INICIAL

Reponer de inmediato sin retirar la placenta.

3.01.2.008 **Hemorragia genital aguda (metrorragia disfuncional-cervicorragia por Cáncer C.U.)**

Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Mioma prolapsado.

PREGUNTA REAL *Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).*

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL **p. 94** Tema 19.18

Clase 19.18 en video

39 TEMA 19.19 · INFECCIONES PUERPERALES

FOTO CLÍNICA

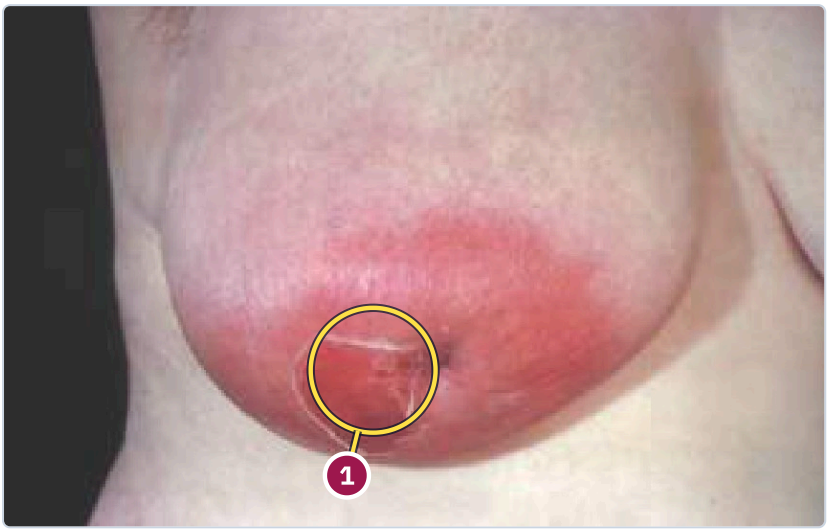


Imagen: Bailey & Love 27.ª ed., Fig. 53.13

QUÉ TIENES QUE VER

1 Absceso

DIAGNÓSTICO

Absceso mamario

Zona fluctuante roja.

CONDUCTA INICIAL

Drenaje; mantener la lactancia del otro lado.

3.01.2.020 Mastitis abscedada
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

SE CONFUNDE CON…

Mastitis: sin colección.

PREGUNTA REAL **Diciembre 2022 · P64** «Una paciente de 32 años, puérpera de parto vaginal eutócico de 8 días de evolución, consulta por dolor mamario derecho, mayor durante la…» → **Suspender la…**

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL
p. 100
Tema 19.19

Clase 19.19 en video

40 TEMA 19.19 · INFECCIONES PUERPERALES

ECOGRAFÍA



Imagen: Williams Gynecology 4.ª ed., Fig. 13-8

QUÉ TIENES QUE VER

1 Colección

DIAGNÓSTICO

Mastitis abscedada: clínica y ecografía

Colección en la ecografía.

CONDUCTA INICIAL

Punción o drenaje.

3.01.2.020 Mastitis abscedada
Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

3.01.2.009 Mastitis puerperal
Dx Específico | Tx Inicial | Seg No requiere

SE CONFUNDE CON…

Galactocele.

PREGUNTA REAL **Agosto 2021 · P176** «Una paciente de 34 años, puérpera hace 15 días, dando lactancia materna, presenta dolor en la mama derecha, de 3 días de evolución, que ha…» → **Iniciar…**

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL
p. 100
Tema 19.19

Clase 19.19 en video

41 TEMA 19.20 · ALOINMUNIZACIÓN RH E INCOMPATIBILIDAD DE GRUPO MATERNO-FETAL

ESQUEMA



Imagen: Dibujo propio (esquema)

QUÉ TIENES QUE VER

1 Feto con anemia

DIAGNÓSTICO

Doppler de ACM en aloinmunización

VSM > 1,5 MoM sugiere anemia moderada o grave.

CONDUCTA INICIAL

Cordocentesis y transfusión.

3.01.3.009 **Prevención de enfermedad hemolítica perinatal**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Feto sin anemia.

PREGUNTA REAL

Agosto 2021 · P74 «Una paciente de 23 años, primigesta, cursando embarazo de 13 semanas, se realiza determinación de grupo sanguíneo, que es informada como AB,...» → **Mantener**...

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL

p. 104

Tema 19.20

Clase 19.20 en video

42 TEMA 19.20 · ALOINMUNIZACIÓN RH E INCOMPATIBILIDAD DE GRUPO MATERNO-FETAL

ECOGRAFÍA

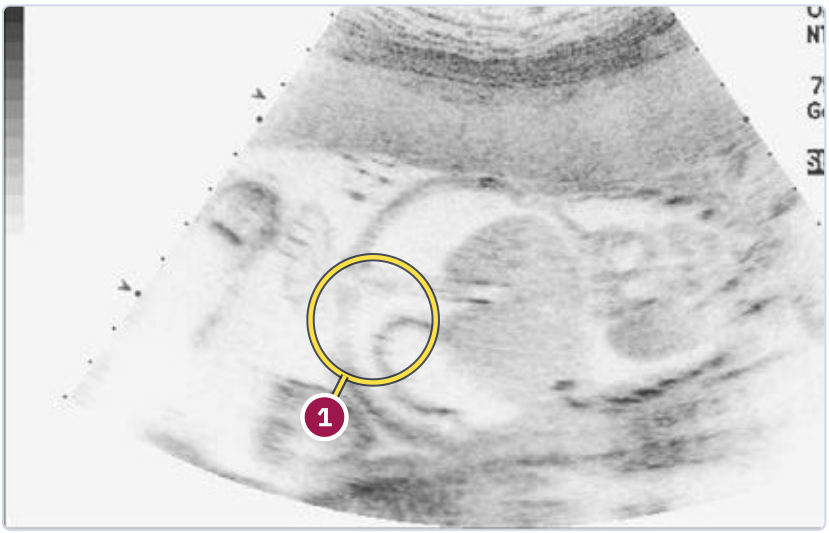


Imagen: Nelson Textbook of Pediatrics, 22nd ed., p. 1437

QUÉ TIENES QUE VER

1 Ascitis

DIAGNÓSTICO

Hidrops fetal

Ascitis, derrame pleural y edema subcutáneo.

CONDUCTA INICIAL

Aloinmunización grave: transfusión intrauterina.

3.01.3.009 **Prevención de enfermedad hemolítica perinatal**

examen/procedimiento

SE CONFUNDE CON…

Ascitis aislada.

PREGUNTA REAL

Sin pregunta real 2013–2025 con este código: practica con la clase (QR).

TOMO OBSTETRICIA Y MEDICINA MATERNO-FETAL

p. 104

Tema 19.20

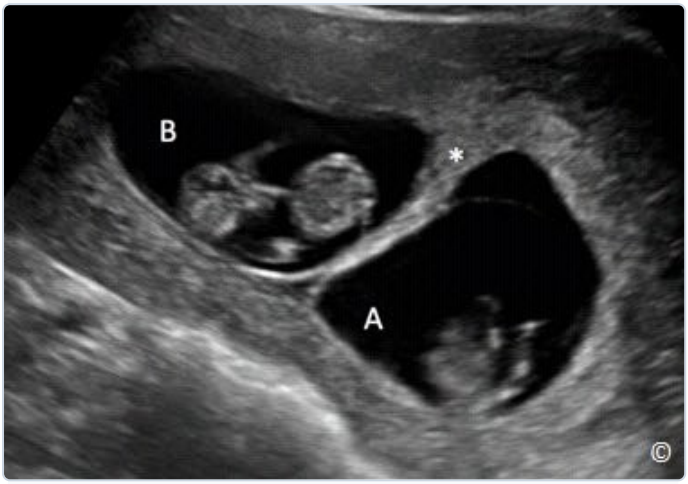
Clase 19.20 en video

Parecidas pero distintas

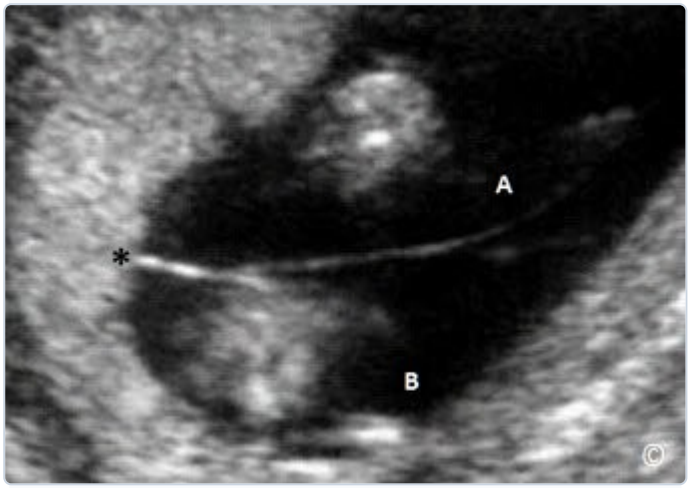
Las mismas fotos de las fichas, lado a lado y sin marcadores: primero intenta decir cuál es cuál.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Bicorial vs monocorial



VS



A Signo lambda: bicorial

- Signo lambda

Ficha n.° 14 · p. 10

B Monocorial: membrana fina

- Signo T

Ficha n.° 15 · p. 11

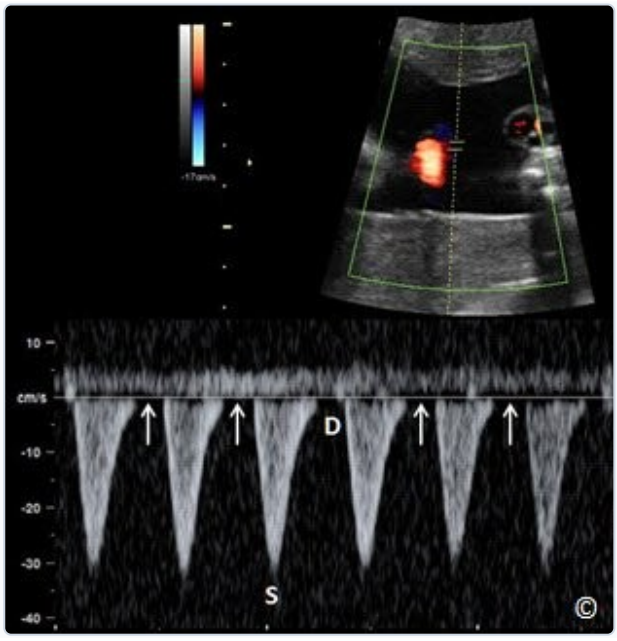
LA DIFERENCIA La monocorial se controla cada 2 semanas.

PARECIDAS PERO DISTINTAS

Doppler umbilical normal vs alterado



VS



A Doppler de arteria umbilical normal

- Diástole presente

Ficha n.° 06 · p. 6

B Flujo diastólico ausente

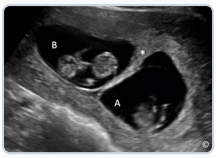
- Diástole ausente

Ficha n.° 08 · p. 7

LA DIFERENCIA Define el momento de interrumpir.

Signos con nombre propio

Lo que el examen nombra con un epónimo o una imagen: qué es, en qué enfermedad aparece y dónde está en el tomo.



SIGNO LAMBDA

Placenta entre las membranas.

Se ve en: Gemelar bicorial.

Tomo p. 44 · Atlas: ficha n.° 14, p. 10



SIGNO DE LA TORTUGA

Cabeza que se retrae contra el periné.

Se ve en: Distocia de hombros.

Tomo p. 89 · Atlas: ficha n.° 33, p. 20



TORMENTA DE NIEVE

Útero con ecos vesiculares sin embrión.

Se ve en: Mola completa.

Tomo p. 62 · Atlas: ficha n.° 23, p. 15

Índice por tipo de imagen

3	1	11	2	24	1
FOTO CLÍNICA	HISTOLOGÍA / CITOLOGÍA	ESQUEMA	TRAZADO (ECG / REGISTRO)	ECOGRAFÍA	PIEZA ANATÓMICA

Foto clínica · 3

33 Signo de la tortuga (19.17) 20
38 Inversión uterina (19.18) 22
39 Absceso mamario (19.19) 23

Histología / citología · 1

29 Test de helecho (19.14) 18

Esquema · 11

05 Registro basal no estresante (19.3) 6
13 Corionicidad y amnionicidad (19.21) 10
22 Útero vacío y β-hCG (19.11) 14
26 Placenta previa vs DPPNI (19.13) 16
27 Tipos de placenta previa (19.13) 17
31 Partograma (19.16) 19
32 Variedades de posición (19.16) 19
34 McRoberts y presión suprapúbica (19.17) 20
36 Balón de Bakri (19.18) 21
37 Balón de Bakri y sutura de B-Lynch (19.18) 22
41 Doppler de ACM en aloinmunización (19.20) 24

Trazado (ECG / registro) · 2

04 Registro cardiotocográfico reactivo (19.3) 5
35 Desaceleraciones precoces (19.17) 21

Ecografía · 24

01 Longitud céfalo-nalgas (19.2) 4
02 Translucencia nucal normal (19.2) 4
03 Translucencia nucal aumentada (19.2) 5
06 Doppler de arteria umbilical normal (19.4) 6
07 Arteria cerebral media vasodilatada (19.4) 7
08 Flujo diastólico ausente (19.4) 7
09 Doppler umbilical alterado (19.4) 8
10 Ductus venoso con onda a reversa (19.4) 8
11 Doppler de arteria cerebral media (19.4) 9
12 Macrosomía: grasa subcutánea aumentada (19.7) 9
14 Signo lambda: bicorial (19.21) 10
15 Monocorial: membrana fina (19.21) 11
16 Transfusión feto-fetal (19.21) 11
17 Gestación interrumpida (19.10) 12
18 Restos ovulares con Doppler (19.10) 12
20 Líquido libre en el Douglas (19.11) 13
21 Embarazo ectópico ampular (19.11) 14
23 Mola completa: tormenta de nieve (19.12) 15
24 Mola: vesículas sin embrión (19.12) 15
25 Placenta previa en la ecografía transvaginal (19.13) 16
28 Vasa previa (19.13) 17
30 Cervicometría (19.15) 18
40 Mastitis abscedada: clínica y ecografía (19.19) 23
42 Hidrops fetal (19.20) 24

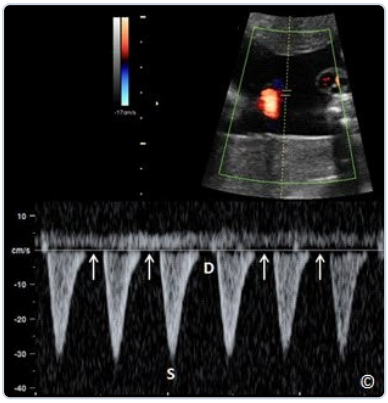
Pieza anatómica · 1

19 Embrión y restos expulsados (19.10) 13

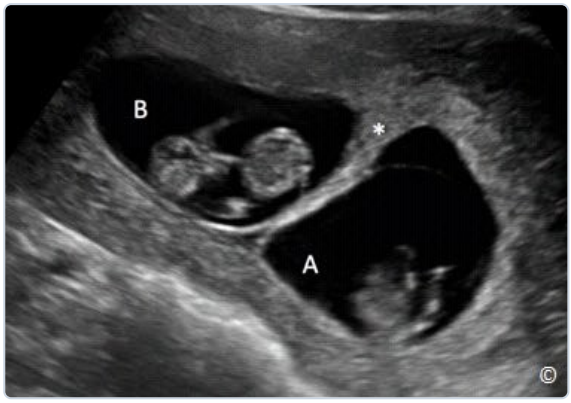
Autoevaluación

6 fotos de las fichas, sin marcadores ni rótulos. Escribe el diagnóstico y el hallazgo que lo confirma; las soluciones están al final.

1 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



2 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



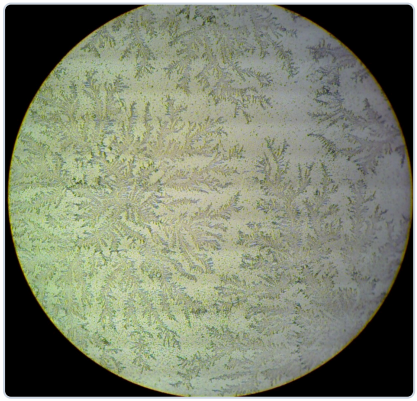
3 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



4 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



5 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



6 ¿Diagnóstico? ¿Qué lo confirma?



Soluciones de la autoevaluación

N.º	DIAGNÓSTICO	LO QUE LO CONFIRMA	FICHA
1	**Flujo diastólico ausente**	Diástole ausente	08 · p. 7
2	**Signo lambda: bicorial**	Signo lambda	14 · p. 10
3	**Embarazo ectópico ampular**	Masa anexial	21 · p. 14
4	**Mola completa: tormenta de nieve**	Patrón vesicular	23 · p. 15
5	**Test de helecho**	Patrón en helecho	29 · p. 18
6	**Signo de la tortuga**	Cabeza retraída	33 · p. 20